HYPERTRIGLYCERIDEMIES CHEZ L'ENFANT A PROPOS DE TROIS (3) CAS

Nom du présentateur : Aïssata KABORE

A Kaboré/Ouédraogo[1], D Kalga[1], G Yaméogo[1], C Zoungrana[2], S Ouédraogo[2], F koueta[2]

1 Service de pédiatrie médicale, CHU pédiatrique Charles de Gaulle

2 Service de pédiatrie, CHU yalgado Ouédraogo

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Hypertriglycéridémie: dyslipidémie caractérisée par une augmentation des triglycérides plasmatiques au delà de 1,5g/L.
- Pathologie pernicieuse : signes modérés ou patents; génétique ou secondaire chez l'enfant; il s'agit d'une pathologie rare
- Diagnostic souvent fortuit chez l'enfant
- Souvent au stade de complications

Objectif

- Rapporter les observations cliniques des cas d'hypertriglycéridémies reçus au CHU pédiatrique Charles DE GAULLE et dans le service de pédiatrie du CHU yalgado OUEDRAOGO de Ouagadougou

Matériel et méthode(s)

- Etude descriptive , rétrospective
- Revue documentaire sur les dossiers de 3 cas
- Cas reçus entre 2021 et 2022 au CHUP CDG et Yalgado
- Analyse des aspects diagnostiques, thérapeutiques
- Détermination des modalités évolutives des cas

Matériel et méthode(s)

❑ Cas 1

- Nouveau né à J17 de vie, reçu pour incapacité de téter, détresse respiratoire
- Pas d'antécédents anténatals chez la mère
- Naissance à terme avec un poids de 3250 g
- Examen: Mauvaise impression générale,SaO2 87%, hypotonie, reflexes archaïques émoussés, détresse respiratoire avec score de sylverman à 5
- **Admission en soins intensifs mais lors des prélèvements sanguins,**

Résultats

Sang lactescent

Bilan lipidique

- Cholestérol total :16,98 mmol/L,
- Triglycérides:10,98 mmol /L ,
- LDL cholestérol :10,51 mmol/L
- HDL cholestérol: 5,53 mmol/L

Glycémie

- 16,8mmol/L.

Résultats

- ❑ Diagnostic d'hypertriglycéridémie est posé

- ❑ **Evolution**

- Oxygénation et réanimation en soins intensifs
- Alimentation lait maternel par sonde progressivement
- Céphalosporine de 3ème génération + aminosides
- Décès au 4ème jour post admission en soins intensifs

Résultats

❑Cas 2

- Nourrisson de 14 mois adressé aux urgences pédiatriques

pour pâleur, fièvre. Etat général conservé, dysmorphie faciale avec face triangulaire, front en balcon, fontanelle antérieure large .**Circulation veineuse importante du cuir chevelu et du front**

Résultats

Sang lactescent

Bilan lipidique

- Triglycérides plasmatiques 56,56 mmol/L
- Cholestérol total:10 mmol/L
- HDL cholestérol: 0,25mmol/L

Glycémie : 2,3mmol/L

Echodoppler cœur: plaques d'athéromes
Ophtalmo: signe de l'arc cornéen
Evolution: AVC par emboles graisseuses
Puis rémission totale sous traitement

Résultats

❑ Cas 3:

Adolescent 12 ans reçu au CHU yalgado pour syndrome oedemato-ascitique

- Diagnostic de syndrome néphrotique est posé, avec signes de compression
- Ponction évacuatrice a ramené une ascite chyleuse; **Bilan lipidique sanguin**
- Triglycérides 5,98 mmol, Cholestérol total à 10,83 mmol/L, LDL cholestérol 7,8mmol/L, HDL cholestérol 2,96mmol/L
- Evolution favorable sous traitement du syndrome néphrotique

Conclusion

- Hypertriglycéridémie est rare chez l'enfant
- Peut être transitoire, mais peut révélé une hypercholestérolomie familiale avec complications thromboemboliques graves
- Traitement est surtout nutritionnel dans notre contexte car formes galéniques des médicaments indiqués non disponibles chez l'enfant

Merci pour votre attention